

Amebíase

Entamoeba histolytica | *Entamoeba coli*



Monitor: Simon Silva
Docente: Dr^a Silvia donato

Agente etiológico e Morfologia

A amebíase é uma doença ocasionada pelo protozoário do gênero *Entamoeba* podendo ser das espécies *histolytica* e *coli* (mais comumente). Habitam o intestino grosso e possuem as formas de **trofozoito e cisto** maduro ou imaturo (forma infectante).

PS: pré-cisto é uma fase intermediária entre trofozoito e cisto, já metacisto é uma forma multinucleada que emerge do cisto no intestino delgado, originando os trofozoitos.

Biologia

Os trofozoitos vivem na luz do intestino grosso, podendo penetrar e produzir ulcerações intestinais.

- Carboidratos como parte de seu metabolismo;
- São anaeróbios, mas podem crescer em atmosferas com até 5% de O₂;
- Se locomovem com o auxílio de pseudópodes;

Ciclo Biológico

1) Ingestão dos cistos (permanecem viáveis cerca de 20 dias fora do hospedeiro) que passam pelo estômago resistindo ao suco gástrico, chegam ao final do intestino delgado ou início do intestino grosso.

2) Desencistamento = saída do metacisto que sofre divisões para originar os trofozoitos.

3) Migração pelo intestino grosso, resultando na colonização - ficam aderidos à mucosa, vivendo como comensais.

4) Desprendem das paredes intestinais, principalmente no cólon, são desidratados, transformando-se em pré-cistos que secretam uma membrana para se transformarem em cistos.

5) Cistos eliminados nas fezes - eles não são encontrados em fezes liquefeitas, nelas haverá presença de trofozoitos.

Pode haver uma **quebra na relação parasito-hospedeiro**, o que faz com que os trofozoitos **invadam a mucosa**, aumentando número de úlceras, bem como **possibilita danos a outros órgãos** através da circulação porta. Podemos denominar esse trofozoito “agressivo” de **trofozoito invasivo**, o qual estará na intimidade tissular, não forma cisto, são hematófagos e muito ativos.



Transmissão

- Ingestão de cistos maduros em alimentos;
- Água sem tratamento contaminada;
- Manipuladores de alimentos assintomáticos;

Patogenia e virulência

Doença é mediante a quebra do equilíbrio parasito-hospedeiro, como citado anteriormente.

- Bactérias anaeróbicas (principalmente) atuam em potencializar a virulência do parasito, outros fatores como: colesterol, passagem em diversos hospedeiros ou reinfecções sucessivas potencializam mais ainda a virulência.

- 1) Invasão do tecido com efeito letal na célula-alvo - isso se dá a partir da adesão mediada por lectinas.
- 2) Rompimento da parede epitelial - movimentos ameboides e liberação de enzimas proteolíticas (hialuronidases, proteases e mucopolissacaridases) que favorecem a progressão e destruição.
- 3) Indução de apoptose e lise osmótica das células-alvo.

As amebas têm dificuldade em penetrar a mucosa, logo aproveitam-se de regiões transglandulares para tal. Multiplicam-se e, em seguida, vão em direção à tecidos mais profundos. Essa migração determina a lesão característica “BOTÃO DE CAMISA” e causam necrose liquefativa, possibilitando infecções bacterianas.

- Lesões são mais frequentes no ceco e região retrossigmoidiana, essas lesões podem evoluir para uma condição de peritonite fecal.

4) Os trofozoitos podem induzir uma resposta inflamatória proliferativa formando uma massa granulomatosa, chamada ameboma (não comum).

- Amebas podem também penetrar vasos e ir aos órgãos, provocando necroses.
- Com relação à imunidade, são diversas respostas devido ao elevado número de antígenos no parasito.

Manifestações Clínicas

Formas assintomáticas e Formas sintomáticas: Intestinal e extra-intestinal (hepática, cutânea, pulmão, baço, rim...)

- Incubação de 7 dias até anos, mas comum entre 3 a 4 semanas.

1) Amebíase intestinal:

a) Assintomática: 80 - 90% dos casos;

b) Sintomática: formas diarreica e disentérica.

- Diarreica: mais frequente, 2 ou 4 evacuações ao dia contendo muco às vezes, desconforto abdominal ou cólicas. Alternância entre sintomas e período silencioso (aumento do peristaltismo);

- Disentérica: modo agudo, muco ou sangue, cólicas intensas, tenesmo, náuseas, vômitos, calafrios, febre. 8 a 10 evacuações ao dia. Em casos mais graves - inúmeras evacuações mucossanguinolentas, febre alta e persistente, prostração, dor abdominal e desidratação;

2) Amebíase extra-intestinal: em vários órgãos. Abscesso amebiano (dentre os tipos de abscesso, **o hepático é o mais comum**), dor, febre e hepatomegalia. Em complicações pode haver perda de peso e rompimento do abscesso.



Diagnóstico

1) Clínico: necessário comprovação laboratorial.

2) Laboratorial: exame parasitológico de fezes.

- Em caso de fezes liquefeitas, exame deve ser rápido (20 - 30 min), pois os trofozoitos logo podem morrer.
- Recolhimento deve ser em dias alternados, pois a eliminação de cistos é irregular e intermitente.
- Para Abscesso amebiano - RX, cintilografia, ultrassom e tomografia computadorizada.

3) Imunológico: raramente utilizados - ELISA e entre outros muitos.

Tratamento e Profilaxia

TTO: Amebicidas que atuam na luz intestinal, tissular ou ambos.

Profilaxia através de engenharias e educações sanitárias, higiene das mãos e, cuidados com a ingestão de alimentos e água.



BONS ESTUDOS!!!

Alguma dúvida???

(83) 98880-7867 | Sala do P4 :)